

통풍, 지금'아플 때부터 평생 관리까지

발작이 왔을 때 무엇을 하고, 요산 약은 언제 시작해 얼마나 오래 먹는지 —
가장 많이 묻는 순서로

지금 아플 때 — 먼저 이 네 가지

빨리 알리고 · 관절을 쉬게 하고 · 냉찜질하고 · 드시던 요산약은 그대로

발작이 시작되면 최대한 빨리 알리고, 다치지 않게 관절을 쉬게 하세요.

통증을 가라앉히는 **불끄기** 약과 몸속 요산을 녹여내는 **청소** 약은 하는 일이 다릅니다. 그래서 기존에 드시던 요산 약은 그대로 드시면서, 급성 통증을 조절하는 약을 함께 복용합니다. 발작이 왔다고 요산 약을 끊으면 혈중 요산이 출렁이면서 통증이 오히려 오래갑니다. 아픈 부위에 핫팩이나 온찜질을 하면 혈관이 넓어져 염증이 더 심해지므로 냉찜질을 하세요. 통증이 심할 때 켜 요산 수치만으로는 통풍이 아니라고 단정할 수 없어, 통증이 완전히 가라앉은 뒤 다시 검사해 정확한 수치를 확인합니다.



찜질

냉찜질

온찜질·핫팩은 염증을 더 키웁니다.

드시던 요산 약

그대로 복용

발작이 와도 스스로 끊지 않습니다.

급성기 약은 세 가지 — 몸 상태를 보고 고릅니다

콜히친 · 소염진통제 · 스테로이드. 콩팥·위장·당뇨·심장 상태에 따라
가장 안전한 약을 선택합니다

선택 · 01

세 약의 효과는 대등합니다

어느 약이 더 센가가 아니라, **지금 내 몸에 가장 안전한 약**이 무엇인가로 정합니다.

약 · 02

콜히친 — 저용량으로

고용량과 효과는 비슷하고 부작용은 적습니다. 같이 먹으면 안 되는 약이 있어 복용 중인 약을 알려주세요.

약 · 03

소염진통제 (NSAID)

콩팥에 부담을 줄 수 있어 피하는 경우가 많습니다. 위장관 출혈·부종·혈압 상승도 주의합니다.

약 · 04

스테로이드

콩팥이 나쁘거나 위장이 약하거나 피 묻게 하는 약을 드실 때 씁니다. 먹는 약·주사 모두 가능합니다.

주의 · 05

당뇨가 있으면 미리 말씀해 주세요

스테로이드는 혈당을 일시적으로 올립니다. 복용 기간에는 혈당을 재 보셔야 합니다.

주의 · 06

두 가지를 같이 쓸 때

함께 쓰면 부작용도 겹칠 수 있어 신중히 정합니다. 셋 다 어려우면 전문의 진료를 권합니다.



불끄기 약과 청소 약은 다릅니다

요산 약(청소 약)은 조건이 맞으면 시작해 오래 유지합니다 —
누가 언제 시작하는지 정리합니다

구분 · 01

두 약은 하는 일이 다릅니다

통증을 가라앉히는 약과 요산을
녹여내는 약은 별개입니다. 요산 약은
고혈압 약처럼 오래 유지합니다.

시작 · 02

꼭 시작하는 경우

통풍결절이 만져지거나, 뼈 손상이
있거나, 발작이 1년에 두 번 이상이면
강하게 권고됩니다.

시작 · 03

상의해서 정하는 경우

콩팥병 3기 이상, 요산 9 mg/dL 초과,
요로결석, 첫 발작이지만 위험 요인이
겹칠 때입니다.

시점 · 04

언제 시작하나

발작이 가라앉고 2~4주 뒤 시작하는
방법이 널리 쓰입니다. 학회마다 권고가
조금씩 다릅니다.

유지 · 05

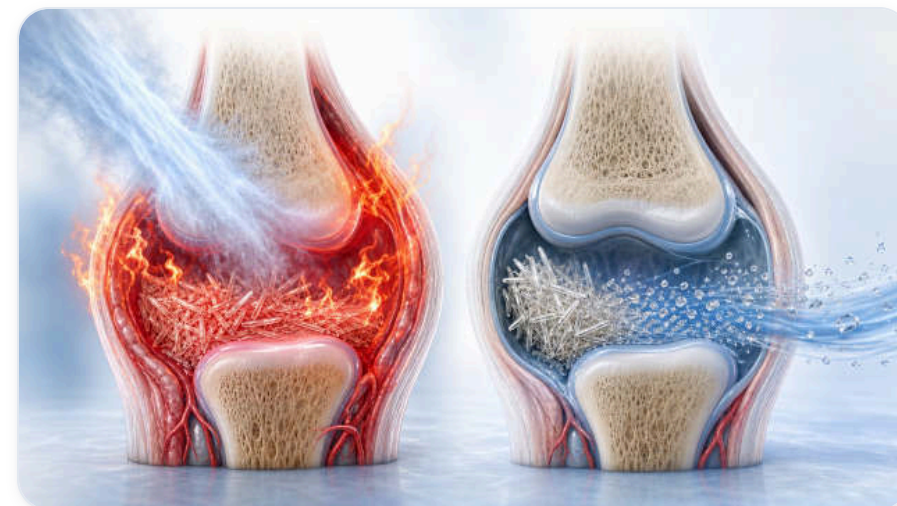
발작이 와도 끊지 않습니다

이상반응이 없으면 발작 중에도 그대로
드세요. 끊으면 요산이 출렁여 통증이
오히려 오래갑니다.

예외 · 06

증상 없이 요산만 높을 때

대개 약보다 생활 관리로 봅니다.
요산결석이나 실제 통풍이 있으면 그
이유로 치료합니다.



요산 약 ① — 알로푸리놀과 페복소스타트

알로푸리놀이 1차약입니다. 낮은 용량으로 시작해 요산을 재면서 목표까지 천천히 올립니다

1차 · 01

알로푸리놀 — 첫 번째 약

요산을 낮추는 1차약입니다. 콩팥 기능이 떨어진 분에게도 1차로 강하게 권고되며, 이때는 시작 용량을 더 낮게 잡습니다.

용량 · 02

낮게 시작해 천천히 올립니다

처음부터 요산이 급하게 떨어지면 오히려 발작이 생기고 과민반응 위험도 올라갑니다. 2~5주 간격으로 요산을 재며 목표까지 증량합니다.

검사 · 03

시작 전 유전자 검사

한국인은 시작 전 **HLA-B*58:01** 검사를 권합니다. 이 유전자를 가진 비율이 서양인보다 높습니다. 양성이면 알로푸리놀을 피하고 다른 약으로 바꿉니다.

2차 · 04

페복소스타트

알로푸리놀이 맞지 않거나 효과가 부족할 때 씁니다. 심장에 대한 위험은 연구마다 결과가 달라 논쟁 중이니, 심장병이 있으면 상의해 정합니다.

요산 약 ②③ — 배설을 돕는 약, 잘 듣지 않을 때의 약

소변으로 요산을 내보내는 약과, 표준 치료로 목표에 닿지 않는 중증에서만 쓰는
주사약이 있습니다

배설 · 01

벤즈브로마론 — 소변으로 내보내기

소변으로 요산을 내보내는 약으로, 국내에서 실제로 쓸 수 있는 배설촉진제입니다. 1차약이
맞지 않거나 부족할 때 단독 또는 함께 씁니다.

주의 · 02

간과 결석은 꼭 확인합니다

드물지만 중대한 간 손상이 있을 수 있어 간기능 검사를 정기적으로 합니다. 요로결석이
있던 분에게는 쓰지 않고, 쓸 때는 물을 충분히 드셔야 합니다.

불응성 · 03

페글로티카제 — 잘 듣지 않을 때

표준 요산 약으로 목표에 닿지 못한 중증 결절 통풍에 쓰는 정맥주사약입니다. 국내에는
아직 도입되지 않아 전문센터 의뢰가 원칙입니다.

구분 · 04

헛갈리기 쉬운 약

라스부리카제는 이름이 비슷하지만 통풍 약이 아니라 암 치료 중 특수한 상황에만 쓰는
약입니다. 두 약 모두 G6PD 결핍이 있으면 쓸 수 없습니다.

약 부작용은 '느껴지는 신호'로 기억하세요

아래 신호가 있으면 약을 멈추고 바로 오세요 — 혼자 참지 마시고 알려주시면 됩니다

즉시 · 01

알로푸리놀 · 페북소스타트

원인 모를 열, 피부 발진, 입안 짓무름, 눈 충혈, 얼굴 부종 — 즉시 중단하고 오세요.

즉시 · 02

콜히친

멈추지 않는 심한 설사, 쥐가 나는 듯한 복통, 근육 통증은 독성 신호입니다.

즉시 · 03

소염진통제 · 스테로이드

검은 변·토혈, 소변량이 갑자기 줄고 붓는 것, 열과 함께 온몸이 처지는 느낌.

검사 · 04

왜 유전자 검사를 하나

아주 드물게 심한 열과 함께 전신 피부가 벗겨지는 부작용이 있어, 미리 위험을 줄입니다.

검사 · 05

음성이어도 방심하지 않습니다

검사가 음성이라고 위험이 완전히 없어지지는 않아, 시작 초기에 발진을 함께 지켜봅니다.

원칙 · 06

참지 말고 알려주세요

알려주시면 용량을 조절하거나 약을 바꿉니다. 정해진 날짜에 꾸준히 재진받으세요.



요산 약을 시작하면 처음엔 발작이 늘 수 있습니다

그래서 요산 약과 함께 '발작을 막는 약'을 최소 3~6개월 같이 씁니다 —
실패가 아니라 예정된 과정입니다

3~6개월

요산 약을 시작하거나 용량을 올릴 때, 발작을 막는 약(저용량 콜히친 또는 저용량 소염진통제)을 최소 3~6개월 함께 씁니다.

왜 같이 쓰나

요산이 초기에 급하게 내려가면 오히려 발작이 생길 수 있습니다. 그래서 약을 낮은 용량부터 시작하고, 발작을 막는 약을 처음부터 같이 넣습니다. 결절이 있거나 발작이 이어지면 기간을 더 늘리고, 목표 수치에 닿고 발작이 없는 것을 확인한 뒤에 이 예방약만 중단합니다. 급하게 살을 빼려고 굶거나 극단적인 저탄수화물·고지방 식사를 하면 오히려 발작이 생기므로, 체중은 천천히 줄이셔야 합니다.

콩팥·심장이 안 좋으면 무엇이 달라지나

약을 못 쓰는 것이 아니라, 고르는 약과 시작 용량이 달라집니다

콩팥 · 01

급성기에는 소염진통제 대신

콩팥에 부담을 줄 수 있어 피하는 경우가 많습니다. 대신 스테로이드를 먹는 약·주사로 씁니다.

콩팥 · 02

요산 약은 그대로 씁니다

알로푸리놀은 콩팥이 나쁜 분에게도 1차약입니다. 시작 용량만 더 낮추고 재면서 올립니다.

심장 · 03

심장병이 있을 때

페북소스타트는 심장병이 있는 분에서 위험이 논쟁 중입니다. 알로푸리놀을 먼저 고려합니다.

심장 · 04

임의 중단이 더 위험할 수 있습니다

스스로 끊으면 오히려 위험이 커질 수 있다는 자료가 있습니다. 끊기 전에 먼저 상의해 주세요.

주의 · 05

특히 조심해야 하는 분

고령, 콩팥병·심부전, 피 묽게 하는 약 복용, 위장관 출혈을 겪은 적이 있는 경우입니다.

예외 · 06

증상 없이 요산만 높을 때

요산 약이 콩팥병 진행을 늦춘다는 근거가 부족해 일상적으로 약을 쓰지 않습니다.

식이 — 무엇을 줄이고, 무엇이 그대로 드셔도 되나

동물성 퓨린과 술·단 음료는 줄이고, 콩·두부·버섯 같은 식물성 퓨린은 제한하지 않습니다

+ 그대로 드셔도 되는 것

- + 콩·두부·버섯·시금치 — 식물성 퓨린은 발작을 늘리지 않습니다
- + 저지방 우유·요구르트 — 오히려 도움이 됩니다
- + 커피 — 위험을 낮춘다는 연구가 있습니다
- + 살코기 위주로 적정량 — 완전히 끊지 마세요
- + 등푸른생선·해산물 — 적당한 양으로
- + 천천히 체중 감량 — 굶는 다이어트는 금물

- 줄여야 하는 것

- 맥주 — 술 중에서 위험이 가장 큼니다
- 소주·양주 — 독주도 요산과 발작을 늘립니다
- 와인 — 위험은 낮지만 총량을 줄이세요
- 콜라·주스·에너지드링크 — 단 음료를 줄이세요
- 곰창·간 등 내장류 · 진하게 우린 곰탕 국물
- 체리·비타민 C 보충제로 약 대신하기 — 근거가 약합니다



목표 수치와 기간, 그리고 바로 오셔야 하는 때

목표는 6 mg/dL 미만, 결절이 있으면 더 낮게. 목표에 닿아도 약은 계속 유지합니다

목표 · 01

6 mg/dL 미만

일반적인 목표 요산 수치입니다. 국내 지침도 국제 표준과 같은 기준을 씁니다.

목표 · 02

결절이 있으면 더 낮게

통풍결절이 있거나 중증이면 5 mg/dL 미만을 목표로 두기도 합니다.

추적 · 03

얼마나 자주 재나

시작·증량 중에는 2~5주 간격, 안정되면 약 6개월 간격으로 콩팥·간기능과 함께 봅니다.

기간 · 04

얼마나 오래 먹나

목표에 닿아도 대개 장기 복용합니다. 결정은 서서히 녹아 일찍 끊으면 다시 쌓입니다.

주의 · 05

임의로 끊으면

요산이 급격히 변해 관절에 쌓인 결정이 흔들리고 통증이 훨씬 오래갑니다. 상의해 정합니다.

즉시 · 06

바로 오셔야 하는 때

열이 나며 여러 관절이 한꺼번에 아프거나, 한 관절이 갑자기 심해지고 온몸이 쳐질 때.



불끄기 약으로 통증을 잡고, 청소 약으로 요산을 낮춥니다

목표는 6 mg/dL 미만 — 꾸준히 유지하면 결절도, 콩팥도, 심장도 함께 지킬 수 있습니다

광교바른내과 진료 안내

평일 08:30~18:30 · 토 08:30~13:30

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층

☎ 031-893-4560

소화기내과 · 일반내과 · 5대암 검진



다시 보기 · 카톡 공유